

藥局供應ECP評估與轉介流程表

藥局辨識民眾是否可購買緊急事後避孕藥

(Emergency Contraceptive Pill, ECP) 之評估與轉介流程表

依據：第 3 場專家會議決議（2026-07-08）+ 日本「懷孕可能性判斷流程」與「緊急事後避孕藥銷售核對表」（經黃建霈秘書長確認可供台灣參採）+ 國際指引（FSRH / ACOG / WHO）之補充。本表為主持人依會議決議整理之**初版（草案）**，將寄發專家於第 4 場會議前檢視。試辦藥品以 LNG（Levonorgestrel）為限。
2026-07-18 修訂（與流程圖、待拍板清單同步）。

流程分兩階段：
階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，於填問卷過程即完成篩選——命中禁忌或須就醫者線上導引就醫、**不產生條碼、不必到藥局白跑**）→ **階段二・到局現場**（本人持 QR Code 到試辦藥局，身分核對後現場評估、供藥）。

三種處置結果：
● **不供藥、直接轉介**（婦產科 / 醫療院所）
● **先供藥+衛教+轉介或通報**（以預防懷孕為第一優先）
● **可供藥**（完成衛教後交付）

● **「提第4場」** = 本流程圖依科學證據繪製，● 標於與第 3 場決議不同、待第 4 場確認之分支（不逕改）。🔗 各項處理建議之理由不在本表贅述；欲知「為何這樣建議」，詳《第4場_流程表待拍板清單》對應議題（議題1-5 / 非議題項）。

一、流程總覽

📄 完整流程圖請見審議平台「藥局判斷流程圖」頁面：<https://yilingwork.github.io/ecp-trial-scheme/flowchart.html>（瀏覽器開啟即可檢視、可列印）——含檢核步驟+結果框、階段一線上 / 階段二藥局分區、醫療與社政轉介分開、● 待第 4 場確認之標註。

本檔以下各節（二～九）為流程圖各步驟之**詳細判斷準則、衛教清單與依據**；流程圖與本檔為同一套內容之兩種呈現，以 HTML 圖為單一視覺來源。

階段一・線上評估（民眾自行上網填寫，尚未到藥局）

於填問卷過程逐步篩選；命中任一 ● 者，系統線上告知就醫、**不產生購藥條碼**。順

序：禁忌 → 懷孕 → 出血 → 時效。

二、① 禁忌檢核（仿單禁忌，任一「是」即●不給藥）

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
1	對 LNG 成分過敏	詢問過敏史	● 轉介（本試辦僅 LNG、無替代品項）
2	嚴重肝功能障礙	依國內仿單禁忌詢問病史	● 轉介（禁忌症）。「嚴重肝功能障礙」指肝硬化、肝衰竭、黃疸、腹水；B 肝帶原、輕度肝功能異常、脂肪肝不屬此列、可正常給藥

非禁忌、正常給藥（勿誤擋）：血栓病史（VTE）、子宮外孕病史、骨盆腔發炎（PID）均非 LNG 禁忌，正常供藥；子宮外孕僅「疑似急性現症」才轉介。●【議題1】

三、② 懷孕可能性評估（依日本核對表，含「3 週驗孕」判準）

📎 本步驟還原第 3 場所參照之日本核對表並補「3 週驗孕」判準（僅「有懷孕徵兆 + 3 週前曾無防護性行為」之窄族群才需驗孕，其餘不需驗孕即可給藥）。設計理由詳議題2。

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
① 徵兆	是否有懷孕徵兆（週期不規則 / 末次月經已逾週期 / 末次月經不確定〔經量少、週期短〕 / 產後流產後月經未恢復）？	無徵兆 → 續問 ③（不需驗孕）；有徵兆 → 續下
② 3 週驗孕	有徵兆者再問：距今**「3 週以前」是否有無防護性行為**？	否（僅近 3 週內發生）→ 不需驗孕、可給藥（服用前追加「不排除本次之前懷孕之可能」說明）；是 → 續下（驗孕）
③ 驗孕	3 週前曾有性行為者 → 使用驗孕棒	陽性 或 不願驗孕 → ● 不給藥、轉介婦產科（確認懷孕位置、排除子宮外孕、產檢）；陰性 → 續問 ③

● 提第4場【議題2】：3 週驗孕判準為新增（第 3 場原文未含）、請專家確認驗孕嚴格度；驗孕執行細節另議。〔厚勞省令和6年度版核對表〕

四、③ 異常陰道出血評估（兩問法）●

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
問 ①	最後一次月經什麼時候？	續下

步驟	詢問 / 判斷方式	處置
問 ②	該次出血與平常月經有無不同（量、天數、顏色）？	續下
判定	不同、說不清楚、或當下正在出血且無法判斷是否為月經	● 轉介婦產科查出血原因（排除子宮外孕、子宮內膜病變等，出血鑑別屬醫師專業）；合併疑似子宮外孕急性徵象（單側劇痛、面色蒼白冒冷汗）→ 視為急診
判定	月經正常、無異常出血	續問 ④

● 提第4場・可改●〔議題3〕：建議改列●「先給藥（保時效）+ 當日轉介查」；僅合併急性子宮外孕徵象維持● 急診。

五、④ 時效窗口（距最近一次未受保護性行為之時數）

時數	判定	處置
72 小時內	LNG 有效	通過線上篩選（時效題於到場當下再重算）
72—96 小時	LNG off-label、無可靠療效數據	● 維持轉介、不給藥（已定案・非議題）；72h 後效果未知（國內仿單：24h 95% / 48h 85% / 72h 58% / >72h 未知），逾時線上即導引就醫、不產生條碼
超過 96 小時	LNG 已無效	● / 轉介婦產科評估 UPA（120 小時內） / 含銅子宮內避孕器（5 日內），口頭告知剩餘時數之急迫性

此為「效果」而非「安全」判斷準則。線上初篩逾 96h 即導引就醫、不產生條碼；72h 內者時效題仍須於到場當下重算（防填答與到場之時間差）。通過 ①—④ → 系統產生 QR Code（購藥條碼）+ 顯示附近可購藥之試辦藥局。

階段二・到局現場（本人持 QR Code 至試辦藥局）

六、⑤ 前置確認（到局身分核對）

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
1	本人親領	掃碼調閱線上填答；核對到場者 = 線上填答者 = 證件本人（不可代購）	不符 → ● 不供藥
2	個資同意	確認線上已簽署個人資料提供同意書	不符 → ● 不供藥

#	檢核項目	詢問 / 判斷方式	處置
3	時效重算	時效題以到場當下重算（時數、當下是否出血）；如已逾時或新增出血 → 回 ④ / ③ 對應處置	逾時 / 新增異常 → 依對應步驟

● **不供藥**：不符本人親領要件（代購 / 身分不符）者，本試辦不予供應；得依現行程序至醫療院所就醫取得。（核對相符、仍在時效內 → 續問 ⑥）

七、● 需醫療 / 社政銜接檢核（● 先供藥 + 衛教 + 轉介 / 通報，以預防懷孕為第一優先）

#	檢核項目	處置
1	疑似性暴力 / 性侵害	先供藥；藥師為責任通報人員，依法 113 通報（單一窗口），由社工介入並陪同至具社工之醫院（一站式服務）就醫採證；避免個案重複陳述
2	性傳染病風險（伴侶已知感染、新 / 陌生伴侶且無套、本人有症狀、多重性伴侶）	供藥 + 建議至婦產科接受性病篩檢
3	短期重複使用（如一個月內再次購買）	供藥（重複使用無嚴重安全疑慮，惟月經易紊亂） + 主動提供常規避孕衛教 + 轉介婦產科 + 納入追蹤
4	哺乳中	供藥 + 衛教。已查證國內 LNG 仿單無「暫停 24h」→ 依國際「可繼續哺乳」（衛教：服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳；非議題）
5	服用肝酵素誘導劑（部分抗癲癇藥、聖約翰草等）	供藥 + 告知效果可能降低 + 詳細諮詢用藥 / 保健食品（台灣得在同意 + 持健保卡下查雲端藥歷核對）。依國內仿單「效果可能降低、告知醫師 / 藥師」、不另設劑量調整；非議題
6	非通報之社會風險個案（脆弱家庭等）	供藥 + 於衛教單提供社福資源 QR Code，鼓勵自主聯繫（不強制轉介、不追蹤）
7	體重過重（>70kg / BMI>26）●	供藥（本試辦僅 LNG） + 告知高 BMI 可能降低效果；是否問卷收集體重 ● 提第4場〔議題4〕

皆「否」→ ● 給藥 + 一般衛教。

八、● 可供藥：標準衛教項目（系統依填答自動帶出個人化清單，藥師逐項確認）

- 盡速服用（越早效果越好）；不強制當場服用（願意者可當場服）。
- 服藥後短時間內（2—3 小時）嘔吐須補服。● 提第4場〔議題5〕：系統「防重複領藥」會擋補服，建議訂「嘔吐補服快速通道」。
- 常見副作用：月經提前 / 延後、點狀出血、噁心、頭痛。

4. **警訊衛教**：月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功；出現下腹劇痛或異常出血應立即就醫（子宮外孕警訊，發生率約萬分之一，惟延誤危險）。
5. ECP 為補救措施、非常規避孕；提供常規避孕與雙重避孕衛教及銜接方式。
6. 衛教單附社福資源與相關諮詢 QR Code。
7. 藥師於系統逐項確認衛教完成 → 完成給藥紀錄、結案（防跨店重複購買）。

各情境對應之個人化衛教清單（系統依填答自動帶出）〔2026-07-16 新增標注〕

「基礎清單」= 上列 1-6 項（盡速服用、嘔吐補服、副作用、警訊衛教、補救≠常規 + 常規避孕銜接、社福資源 QR）。系統依線上填答與現場評估結果，於基礎清單上**自動加掛**該情境之加值衛教項目（連動資訊系統功能 B-6 「個人化衛教清單」）。

情境（處置結果）	衛教清單內容
● 一般供藥	基礎清單 1-6 （全員必做）
● 疑似性暴力 / 性侵害 (6-1)	基礎清單 + 113 通報與一站式服務流程說明 （就醫會經歷什麼、社工陪同）+ 保留證據提醒 + 心理支持資源
● 性傳染病風險 (6-2)	基礎清單 + 性病篩檢衛教 （建議婦產科篩檢項目、windows period 概念）+ 保險套正確使用
● 短期重複使用 (6-3)	基礎清單 + 強化常規避孕衛教 （LARC 等選項比較、轉介婦產科避孕諮詢）+ 月經紊亂預期說明 + 追蹤說明
● 哺乳中 (6-4)	基礎清單 + 哺乳衛教 （已查證國內仿單無「暫停24h」→ 依國際「可繼續哺乳」；衛教服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳）
● 服用肝酵素誘導劑 (6-5)	基礎清單 + 交互作用衛教 （效果可能下降之告知、後續避孕加強措施）
● 非通報之社會風險個案 (6-6)	基礎清單 + 社福資源引導強化 （QR Code 內容逐項說明、鼓勵自主聯繫）
● 不供藥、直接轉介	無供藥衛教；改為 就醫指引 （轉介事由說明、就醫時效急迫性〔UPA≤120h / 含銅 IUD≤5 日〕、就醫會經歷什麼）+ 轉介單
● 不符本人親領	替代途徑告知 （現行就醫程序、時效急迫性）+ 記錄已告知時間

九、依據與待確認事項

- 各 ● 項之國際實證與改動理由，詳《第4場_流程表待拍板清單》（第四次專家會議資料夾）議題1-5 / 非議題項及附錄（國際實證依據）——一句話：真正「因給藥不安全而須擋」者僅「LNG 成分過敏」，其餘 ● 皆屬「效果」或「診斷把關」、給 LNG 本身安全。
- 國際指引（FSRH / ACOG / WHO）原則：供應 ECP 前**不需內診或驗孕**、**不得因體重 / 肥胖拒絕供應**；本流程之驗孕關卡係採日本模式（僅於懷孕可能性

存疑時實施)，設計理由為「防誤判、即時轉介」而非安全風險。

- 體重過重 (>70 kg 或 BMI>26) 處置方式與是否即刻於問卷收集體重資料，
● 待第 4 場確認〔議題4〕。
- 未成年（兒少）之供藥條件與家長同意，第 4 場（第 8 章）討論後補入（未滿 16 歲之通報屬現行法，須先於流程加年齡節點）。
- 追蹤機制（第 21 天追蹤、追蹤方式）第 5 場（第 12、13 章）討論後補入。
- 本表已規劃函詢衛福部保護司（性暴力個案之法定通報管道與 113 之關係、24 小時時限、轉介操作）。函詢時點：俟第 4 場會議確認所有轉介情境後再一併函詢（避免情境未定即函詢、需反覆行文）。